

Physioguide — Clínica — Rotura del bíceps distal

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Hook test, biceps squeeze; cluster B — ver knowledge/evidence/elbow-wrist-tests-expansion.md

Principles: Ver knowledge/PHYSIOGUIDE_MASTER_CLINICAL_DOCUMENT.md

1. DEFINITION

Rotura del bíceps distal = interrupción (completa o parcial) del tendón del bíceps en su inserción radial (tuberosidad bicipital), típica en varón de mediana edad con carga excéntrica (levantar, “pop” antecubital).

No es epicondralgia. No es “contractura”. Es un síndrome de presentación traumática que exige reconocer el pop, el contorno, la supinación débil y el hook test.

2. TYPICAL LOCATION

> «Señala dónde notaste el chasquido y dónde te falla la fuerza.»

- Ubicación — Interpretación
 - Fosa antecubital / pliegue del codo — Bíceps distal
 - Vientre del bíceps retraído (“bola”) — Completa con retracción
 - Epicóndilo lateral — LET — otro árbol
 - Dolor anterior sin pop — Cabeza radial, pronador, bursitis
-

3. HISTORY (obligatoria)

- Pop o chasquido audible/sentido al levantar un peso
 - Carga excéntrica (coger una caja, curl, trabajo)
 - Equimosis antecubital tardía
 - Debilidad al girar (destornillador, llave) más que al flexionar
 - Edad, mano dominante, tabaco/esteroides (contexto, no diagnóstico)
 - Pregunta clave: «¿Notaste un chasquido delante del codo y ahora no giras la palma con fuerza?»
-

4. MECHANISM

- Mecanismo — Hipótesis !'
 - Carga excéntrica + pop — Rotura distal
 - FOOSH — Cabeza radial / fractura
 - Insidioso sin pop — Tendinopatía / LET / pronador
 - Herida abierta — Laceración (cirugía)
-

5. RED FLAGS

- Sospecha de rotura completa (hook ausente + pop + supinación débil) !' derivación médica precoz (ventana de reparación)
 - Déficit vascular/neurológico, deformidad, herida
 - No infiltrar “epicondilitis” ni forzar Cozen como plan único
-

6. EXAM CLUSTER

POP ANTECUBITAL

+ PÉRDIDA DE CONTORNO / HUECO

+ SUPINACIÓN DÉBIL (flexión puede estar relativamente conservada)

+ HOOK TEST: no se engancha el tendón (lado sano sí)

± SQUEEZE sin supinación

!' ROTURA COMPLETA COMPATIBILITY !' !' DERIVACIÓN

Hook enganchable + dolor + pop leve !' posible parcial !' imagen (eco/RMN), no alta como LET.

7. DIFFERENTIAL

- Entidad — Discriminador
 - LET — Dolor epicóndilo, Cozen, sin pop ni hueco
 - Cabeza radial — FOOSH, pronosupinación dolorosa, RX
 - Pronador / mediano proximal — Parestesias medianas, sin pop
 - Braquial — Flexión más afectada, patrón distinto
 - Luxación — Deformidad, no mueve
-

8. IMAGING / ACTION

- Clínica de completa !' no retrasar derivación esperando "a ver si pasa"
 - Parcial o duda !' ecografía/RMN
 - RX si trauma mixto (cabeza radial)
-

9. AI RULES

- Nunca: Cozen positivo = bíceps.
- Nunca: hook enganchable = tendón sano al 100 % (parcial).
- Nunca inventar Sn/Sp. Citar O'Driscoll 2005 como serie de completas.
- Lenguaje: «compatible con rotura distal», «sospecha alta», «derivación», no «confirmado» sin imagen/cirugía.

Citation: O'Driscoll SW et al. *Am J Sports Med.* 2005. Ruland squeeze *Clin Orthop.* 2005. Revisiones JAAOS/JSES distal biceps.

